

Hepatites virais - A, B, C e agudização

Leia o painel sorológico como uma história temporal. HAV é aguda/fecal-oral; HBV pode cronificar e tem vacina; HCV cronifica com frequência e tem cura com DAAs.

Painel HBV em uma linha

Dica - Painel HBV em uma linha

HBsAg+ = infecção. Anti-HBs+ isolado = vacina. Anti-HBc+ com anti-HBs+ = infecção pregressa. IgM anti-HBc+ sugere agudo.

Triagem R1: via de transmissão + sorologia típica + desfecho (cura × cronicidade).



Condutas que caem

- HAV: suporte; imunoglobulina/vacina em contatos conforme cenário
- HBV agudo: suporte; antivirais em falência grave / reativação / imunossupressão
- HCV: genótipo menos decisivo hoje — tratar com DAA após confirmação de viremia
- Coinfecção HBV/HDV e HIV: piora evolução — sempre rastrear fatores de risco

Marcadores — atalhos

Marcador | Significado

IgM anti-HAV | Hepatite A aguda

HBsAg | Infecção HBV (aguda ou crônica)

HBeAg | Alta replicação / infectividade

Anti-HCV + RNA-HCV | Infecção HCV ativa

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Antes de imunossupressão/quimioterapia em HBsAg+ ou anti-HBc+, considere profilaxia antiviral — reativação de HBV pode ser fulminante. Não confunda anti-HBs vacinal com infecção ativa.